Établissement

Médecin

CONDUITE À TENIR — AS · AES · ÉDUCATEURS

Ruptures d’approvisionnement

Médicament ou dispositif manquant, non livré ou en rupture annoncée : alerter tôt, ne rien remplacer soi-même, appliquer la consigne écrite.

1 · Je repère

- Boîte presque vide, livraison incomplète, message de rupture de la pharmacie.
- Dispositif manquant : poches, sondes, bandelettes, lancettes, consommables d’oxygène.
- **Alerter sans attendre la dernière prise.**

2 · Je vérifie

- Quel produit exactement (nom, dosage, forme) ? Pour qui ? Combien de prises restent ?
- **Médicament critique ?** antiépileptique, insuline, anticoagulant, antiparkinsonien, corticoïde, traitement palliatif.
- Disponible dans la dotation d’urgence ou une autre unité ? (l’IDE décide).

3 · J’agis

- Prévenir l’**IDE** : elle voit avec la **pharmacie** et le **médecin**.
- Appliquer **uniquement la consigne écrite** (produit, dosage, horaire) de l’IDE, du médecin ou du pharmacien.
- Boîte d’aspect différent (générique, autre laboratoire) : faire vérifier par l’IDE avant la 1re prise.
- Transmettre la consigne retenue à l’équipe suivante.

Je ne fais pas

- **Remplacer** par un autre médicament, dosage ou forme sans consigne écrite.
- **Emprunter** le traitement d’un autre résident.
- Couper, écraser ou déconditionner pour « faire durer ».
- **Arrêter** ou sauter un médicament critique sans décision médicale.

J’alerte

Avis médical sans délai (astreinte, DOTR ; à défaut 15) si :

- **Médicament critique** manquant pour la prochaine prise.
- Prise sautée et signes d’aggravation (crise, glycémie anormale, raideur, douleur).
- Traitement vital impossible à donner et médecin injoignable : **15**.

J’informe l’IDE le jour même si :

- Toute boîte manquante, livraison incomplète ou message de rupture.
- Boîte d’aspect inhabituel ou changement de laboratoire.
- Dispositif ou consommable manquant.

Je suis et je trace

- Tracer : produit, date, démarches, réponses de la pharmacie et du médecin, consigne retenue.
- Après changement de produit : efficacité, tolérance, comportement ; tout changement à l’IDE.
- Rupture qui dure ou touche plusieurs résidents : informer le cadre et le médecin coordonnateur.

Mention de sécurité

Une rupture se signale tôt et se règle par une consigne écrite de l’IDE, du médecin ou du pharmacien. L’équipe ne remplace, n’emprunte et n’arrête rien d’elle-même.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ANSM, Disponibilité des produits de santé (ruptures, MITM) ; CSP L5121-29 et s. (ruptures, MITM), L5125-23 (substitution par le pharmacien) ; CASF D312-160 (plan bleu) et L313-26 ; arrêté du 26/06/2026, art. 2.

Réf. DOTR-AS-RUPT | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature